

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ : ETN Service Ondemand

2. ผลงานประเภท : CQI

3. คำสำคัญ : ET Nurse , Colostomy Care , Advance Wound Care, Incontinence associated dermatitis (IAD)

4. สรุปผลงานโดยย่อ :

ระบบบริการพยาบาลที่หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กเล็กพัฒนาขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และวิธีปฏิบัติแก่ทุกหน่วยงานในสถาบันฯ ที่มีปัญหาใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การดูแลผู้ป่วยที่เปิดลำไส้ทางหน้าท้อง 2) แผลกดทับ (Pressure injury) 3) ผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่าย (Enterostomal Therapy Nurse : ET Nurse) เริ่มจากการดูแลผู้ป่วยในหน่วยงาน และขยายไปในหน่วยงานอื่นที่เป็นทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เนื่องจากมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ในระยะเริ่มต้นของการให้คำปรึกษาหอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กเล็กใช้วิธีโปรมท 2 รูปแบบ ถ้าเป็นผู้ป่วยในจะเสนอความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่มีปัญหา โดยการโทรศัพท์แจ้งชื่อ และปัญหาของผู้ป่วยจะมี ET Nurse ไปดูแล ให้คำแนะนำ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ส่วนผู้ป่วยนอกโปรมทกับแพทย์ที่ออกตรวจ หากพบผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูแลสามารถโทรแจ้งและส่งผู้ป่วยมารับคำปรึกษาที่หอผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะลงไปดูให้ที่ห้องตรวจศัลยกรรมผู้ป่วยนอก มีการสร้าง Line Official เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยดูแล ติดตามปัญหา ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่เปิดลำไส้ทางหน้าท้อง ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ และผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่เปิดลำไส้ทางหน้าท้อง ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ และผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ได้รับการประเมินและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่เปิดลำไส้ทางหน้าท้อง ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ และผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

3. เพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

หอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กเล็กให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางศัลยกรรม โดยผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง (Ostomy) เป็นกลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเฉพาะทาง ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบทางเดินอาหาร จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบาย อูจจาระออกทางหน้าท้อง การเปิดลำไส้ทางหน้าท้องส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว ซึ่งต้องปรับตัวและเรียนรู้ทักษะการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยที่เปิดลำไส้ทางหน้าท้องของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2567 พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะผิวหนังระคายเคืองรอบรูเปิดลำไส้ (Peristomal Skin Complications) ร้อยละ 35.44 ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่บอบช้ำและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สาเหตุสำคัญเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องในการดูแลของบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ดูแล ส่งผลให้เกิดความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานขึ้น

นอกจากนี้การเกิดแผลกดทับ และภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ (Incontinence-Associated Dermatitis: IAD) ยังเป็นปัญหาที่พบในผู้ป่วยเด็กที่มีความเจ็บป่วยซับซ้อนและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเจ็บปวด เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องอาศัยการประเมินปัญหาอย่างถูกต้อง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการดูแลแผลที่เหมาะสม ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง

ปัจจุบันสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการเปิดลำไส้ทางหน้าท้อง เกิดแผลกดทับ และภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางคลินิก ระยะเวลาการรักษา ดังนั้นหอผู้ป่วยกุมารศัลยกรรมเด็กเล็กจึงได้พัฒนาระบบบริการพยาบาลเฉพาะทางด้านออสโตมี แผล และการควบคุมการขับถ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยพยาบาลผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับการปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่บุคลากรและผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

7. กิจกรรมการพัฒนา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2567 ถึง ปัจจุบัน

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลเฉพาะทางด้านแผล ออสโตมี และการควบคุมการขับถ่าย (ET Nurse Service System) ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA Cycle (Plan-Do-Check-Act) เป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบระบบบริการ

Cycle 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย

Plan

1. ทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาการดูแลผู้ป่วยที่เปิดลำไส้ทางหน้าท้อง แผลกดทับ และภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พบว่า ผู้ดูแลขาดความรู้ และทักษะ ขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย แก้ไขปัญหาได้ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
3. วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่งพยาบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่าย

Do

1. พยาบาล ET Nurse ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาภายในหน่วยงาน
2. รับปรึกษาผู้ป่วยจากหน่วยงานอื่น และให้คำแนะนำเฉพาะราย
3. บันทึกข้อมูลลักษณะแผล ภาวะแทรกซ้อน การรักษา และผลลัพธ์การดูแล
4. ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

Check

1. ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหลังได้รับการดูแล
2. ไม่พบภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น
3. พยาบาลและผู้ดูแลสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้

Act

1. ติดตามผลการรักษาทุก 3-5 วันจนแผลหาย
2. ทบทวนผลการดำเนินงาน พบว่ายังมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

3. วิเคราะห์สาเหตุเพิ่มเติม พบว่า พยาบาลและผู้ดูแลยังขาดความรู้ในการประเมินปัญหา การเข้าถึง ET Nurse ยังไม่รวดเร็ว บุคลากรบางหน่วยงานยังไม่ทราบช่องทางการปรึกษา ET Nurse วัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสม

Cycle 2 พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและการสื่อสาร

Plan

1. นำผลการทบทวนจาก Cycle 1 มาวิเคราะห์
2. กำหนดเป้าหมายให้ ET Nurse เยี่ยมผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับการปรึกษา
3. สื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อโปรโมทการให้คำปรึกษา
4. วางแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ

Do

1. จัดทำแบบฟอร์ม Consult ET Nurse
2. กำหนดแนวทางการตอบรับ Consult ภายใน 24 ชั่วโมง
3. จัดทำ Line Official สำหรับการปรึกษาและติดตามอาการ
4. จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่เปื่อยล้าได้ทางหน้าท้อง และโครงการ Baby Skin Care and Advanced Wound Care เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย

Check

1. ผู้ป่วยได้รับการประเมินโดย ET Nurse ภายใน 24 ชั่วโมง
2. อาการผู้ป่วยดีขึ้นหลังได้รับการดูแล
3. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
4. ประเมินความพึงพอใจของพยาบาล ผู้ป่วย และผู้ดูแล

Act

1. ปรับปรุงระบบ Consult ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่ายผ่าน Line Official
3. รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิกเพื่อใช้พัฒนาระบบ

Cycle 3 พัฒนาสู่ระบบบริการมาตรฐานและความยั่งยืน

Plan

1. ทบทวนข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิกและความพึงพอใจ
2. วิเคราะห์โอกาสพัฒนาระบบในระดับองค์กร

Do

1. พัฒนาศักยภาพพยาบาลประจำหน่วยงานผ่านการ Coaching และ On-the-job Training
2. จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วย

Check

1. ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองภายใน 24 ชั่วโมงตามเป้าหมาย
2. อัตราการแก้ไขปัญหาสำเร็จ $\geq$ ร้อยละ 80
3. บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

Act

1. ขยายระบบ ET Nurse Service System ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสถาบัน
2. กำหนดเป็นระบบบริการมาตรฐานขององค์กร

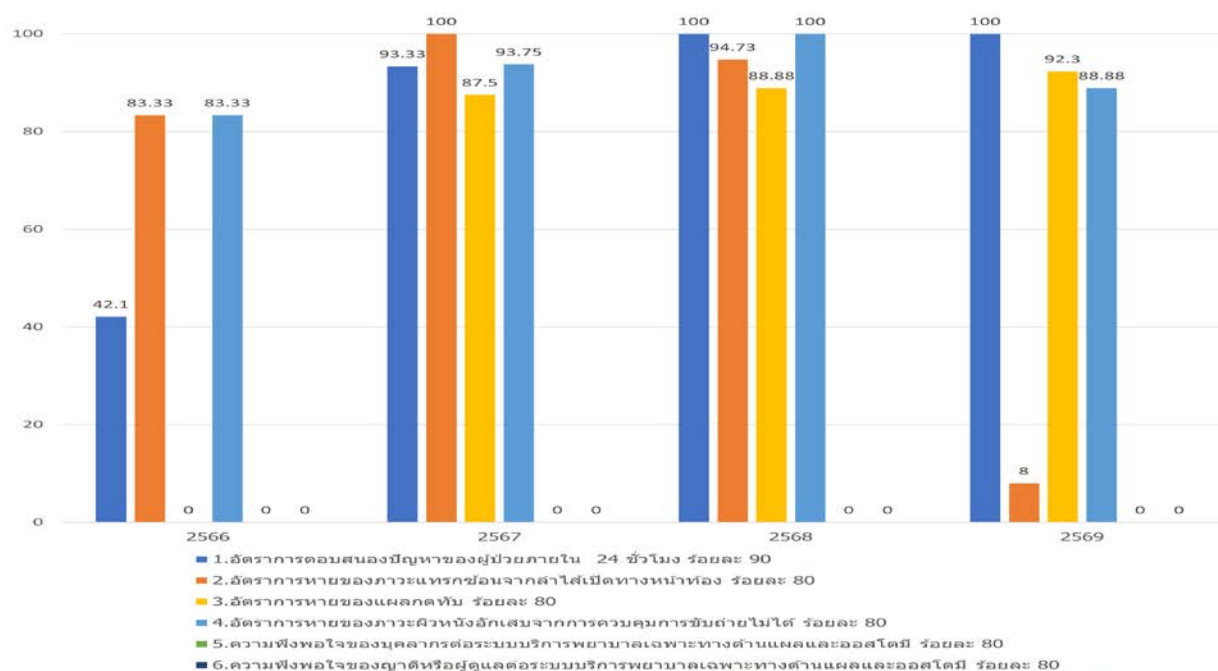
3. ติดตามตัวชี้วัดและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

- 1.ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองต่อปัญหาภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับคำปรึกษา $\geq$ ร้อยละ 90
- 2.อัตราการหายของภาวะแทรกซ้อนจากลำไส้เปิดทางหน้าท้อง $\geq$ ร้อยละ 80
- 3.อัตราการหายของแผลกดทับ $\geq$ ร้อยละ 80
- 4.อัตราการหายของภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ $\geq$ ร้อยละ 80
- 5.ความพึงพอใจของบุคลากรของหน่วยงานที่ขอปรึกษา $\geq$ ร้อยละ 80
- 6.ความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อการบริการ $\geq$ ร้อยละ 80

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ : ระบุ

ตัวชี้วัด	2566	2567	2568	2569
1.ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองต่อปัญหาภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับคำปรึกษา $\geq$ ร้อยละ 90	42.10	93.33	100	100
2.อัตราการหายของภาวะแทรกซ้อนจากลำไส้เปิดทางหน้าท้อง $\geq$ ร้อยละ 80	83.33	100	94.73	8 8.88
3.อัตราการหายของแผลกดทับ $\geq$ ร้อยละ 80	NA	87.50	88.88	92.30
4.อัตราการหายของภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ $\geq$ ร้อยละ 80	83.33	93.75	100	88.88
5.ความพึงพอใจของบุคลากรของหน่วยงานที่ขอปรึกษา $\geq$ ร้อยละ 80	NA	NA	กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการ
6.ความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อการบริการ $\geq$ ร้อยละ 80	NA	NA	กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการ



10. บทเรียนที่ได้รับ :

จากการพัฒนาระบบบริการพยาบาลเฉพาะทางด้านแผล ออสโตมี และการควบคุมการขับถ่าย (ET Nurse Service System) พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เอง ผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร ผู้ป่วยที่มีภาวะชักเกร็งหรือข้อติดแข็ง เป็นต้น จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมการหายของแผลได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาลนานขึ้น นอกจากนี้อุปกรณ์ ADVANCE WOUND CARE มีราคาสูง ผู้ปกครองต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยหากต้องดูแลทำแผลเองที่บ้าน ในการมาตามนัดทุกครั้งจึงอาจทำให้แผลแย่งได้

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน :

1.นางสาววิชชุดา เครือเทศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กุมารศัลยกรรมเด็กเล็ก (ส6เอ) ติดต่อ 092-269-6747 Email : vichuladakt@gmail.com

2.นางสาววิมลสิริ เหล่าภักดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กุมารศัลยกรรมเด็กเล็ก (ส6เอ) ติดต่อ 080-912-2728 Email : un.laopakdee@gmail.com